

Établissement

Médecin DOTR destinataire

CHECK-LIST DE PRÉPARATION — TÉLÉCONSULTATION / TÉLÉEXPERTISE

Troubles urinaires

Brûlures, urines troubles, fuites nouvelles, suspicion d'infection urinaire. À remplir avant le créneau de télé-médecine et à déposer dans le dossier du résident.

Appeler sans attendre le créneau si l'un de ces signes est présent

- ☐ Fièvre $\geq 38,5$ °C ou frissons
- ☐ Douleur d'un rein, sur le côté ou dans le dos
- ☐ Confusion d'apparition récente, chute inhabituelle
- ☐ Vomissements
- ☐ Tension systolique < 90 mmHg, marbrures, extrémités froides
- ☐ Aucune urine émise depuis plus de 8 à 12 heures
- ☐ Envie d'uriner impérieuse sans y parvenir, ventre dur au-dessus du pubis
- ☐ Urines très rouges, avec caillots

Appel du médecin DOTR sans attendre le créneau. Appel du 15 en cas de sepsis suspecté — fièvre avec frissons et confusion, tension basse, marbrures. Une rétention aiguë d'urine est une urgence : ne pas attendre le créneau.

1. Le résident et la question

Nom et prénom du résident

Question posée au médecin

Pièces à joindre — seulement si nécessaire

Si nous avons accès au logiciel de l'établissement, ne rien joindre : tout y est déjà consultable.

- ☐ Établissement sans logiciel accessible — joindre ordonnance, antécédents, allergies, bilans
- ☐ Information importante pas encore saisie dans le logiciel — laquelle
- ☐ Niveau de soin ou directives anticipées à signaler
- ☐ Photos et vidéos — dans tous les cas

2. Signes urinaires

Fréquence des mictions

- ☐ Habituelle
- ☐ Augmentée
- ☐ Diminuée
- Depuis quand

Signes ressentis ou observés

- ☐ Brûlures en urinant
- ☐ Envies pressantes
- ☐ Douleur au-dessus du pubis
- ☐ Douleur d'un rein ou du dos
- ☐ Fuites nouvelles ou aggravées
- ☐ Plaintes ou gémissements en urinant
- ☐ Aucun signe exprimé — résident non communicant

Aspect des urines

- ☐ Foncées, concentrées
- ☐ Troubles
- ☐ Malodorantes
- ☐ Sang visible

3. Terrain et facteurs favorisants

Sonde urinaire

- ☐ Pas de sonde
- ☐ Sonde à demeure
- ☐ Sondages répétés
- Date de la dernière pose
- Motif de la sonde

Antécédents urinaires

- ☐ Infections urinaires documentées et répétées
- ☐ Hypertrophie de la prostate
- ☐ Vessie neurologique connue
- ☐ Lithiase ou colique néphrétique
- ☐ Insuffisance rénale connue

Antibiotique récent

- ☐ Aucun
- ☐ Oui — lequel
- Date de fin

Chez la femme en âge de procréer

- ☐ Grossesse possible

3 bis. Hydratation, transit, autonomie

Hydratation

- ☐ Environ 1,5 L par jour ou plus
- ☐ Insuffisante

Transit

- Date des dernières selles
- ☐ Constipation en cours
- ☐ Diarrhée en cours

Continence et hygiène

- ☐ Continent
- ☐ Incontinent le jour
- ☐ Incontinent la nuit
- ☐ Port de protections
- Changes par 24 h
- ☐ Toilette intime autonome
- ☐ Toilette intime avec aide

Mobilité

- ☐ Va aux toilettes seul
- ☐ Accompagné aux toilettes
- ☐ Alité

4. Fièvre et retentissement général

Température

Valeur la plus haute

Depuis quand

☐ Frissons

Antipyrétique

☐ Non administré

☐ Administré — efficace

☐ Administré — sans effet

État général

☐ Conservé

☐ Altéré

Signes qui, chez la personne âgée, peuvent être les seuls

☐ Confusion récente

☐ Chute inhabituelle

☐ Refus alimentaire

☐ Agitation ou agressivité nouvelles

☐ Aggravation d'une incontinence

4 bis. Bandelette urinaire

La bandelette ne se lit que chez un résident qui a des signes. Une bandelette positive sans symptôme ne veut pas dire infection et ne justifie pas d'antibiotique.

Chez un résident porteur de sonde

☐ Résident sondé — bandelette non contributive, ne pas la réaliser
Chez un porteur de sonde, la présence de germes est constante : ni la bandelette ni l'ECBU ne permettent d'affirmer une infection. Seuls les signes cliniques comptent.

Résultat — résident non sondé

☐ Non réalisée

☐ Leucocytes positifs

☐ Nitrites positifs

☐ Sang

☐ Bandelette négative sur leucocytes et nitrites

Date et heure du test

ECBU

☐ Non réalisé

☐ Prélevé, en attente

Date du prélèvement

5. Éléments infirmiers

À remplir par l'IDE ou l'IDEC. En l'absence d'infirmier au moment du recueil, cocher la case ci-dessous et laisser la suite vide.

☐ Aucun infirmier présent au moment du recueil

Paramètres

Tension artérielle

Pouls

Température

Saturation

Examen

☐ Douleur à la palpation au-dessus du pubis

☐ Douleur à la palpation d'une fosse lombaire

☐ Globe vésical palpé

☐ Bladder scan réalisé — volume en mL

Biologie déjà disponible dans le dossier

Créatinine — valeur et date

CRP — valeur et date

☐ Aucun bilan récent disponible

6. Photos et vidéos à déposer dans Healphi

☐ Plan large, environ 30 s — état général, comportement, niveau de vigilance

☐ Palpation au-dessus du pubis, environ 30 s, en filmant le visage du résident pour repérer la douleur

☐ Palpation des fosses lombaires, environ 30 s, à droite puis à gauche

☐ Photo du recueil d'urines, pour l'aspect et la couleur

☐ Photo de la bandelette, prise dans le délai de lecture, à côté de son étiquette de référence

Où déposer — canal unique

☐ Dossier du résident dans Healphi

☐ Messagerie Healphi

☐ Partage d'écran pendant la visio

Aucun envoi par WhatsApp, SMS ou messagerie personnelle.

Mention de sécurité

Cette check-list prépare un avis médical : elle ne le remplace pas et n'autorise aucun traitement. Devant un signe du cadre rouge, appeler sans attendre le créneau. Une bandelette positive sans symptôme correspond le plus souvent à une colonisation et ne se traite pas. Les protocoles DOTR Infection urinaire / Cystite suspectée et Cystite simple restent applicables dans leurs conditions propres. Document et pièces jointes tracés dans le dossier.

Rempli par (nom, fonction) :

Le : / / à h

Déposé dans le dossier Healphi du résident : ☐ oui ☐ non